

Từ nguyên tắc đến vận hành: đạo đức và quản trị AI trong y học tại Việt Nam
Bản thảo thử nghiệm G7 — chỉ để kiểm tra hợp đồng xuất bản

Trạng thái:

G7 MOCK COMPLETE PENDING HUMAN LAYOUT AND CITATION CHECK

Không phải kết quả nghiên cứu: các nguồn Việt Nam bên dưới là tập mô phỏng có locator trong registry thô; không có quyết định eligibility, kết quả tổng hợp hay kết luận khoảng trống nào được suy ra từ bản này.

Tóm tắt tiếng Việt

Đặt vấn đề: AI trong y học đòi hỏi các kiểm soát về an toàn, quyền người bệnh, công bằng, trách nhiệm và giám sát. Bằng chứng công khai tại Việt Nam trải trên y văn, tài liệu chính thức và nguồn triển khai, nên cần một tổng quan phạm vi có truy vết nguồn rõ ràng.

Mục tiêu: Kiểm tra khả năng trình bày một tổng quan phạm vi về đạo đức và quản trị AI trong y học tại Việt Nam trong giới hạn tám trang của tạp chí.

Phương pháp: Đây là mock manuscript theo protocol OSF, dùng 25 tham chiếu đại diện và 16 record Việt Nam mô phỏng, có locator và trường dữ liệu tối thiểu. Tìm kiếm, sàng lọc kép, trích xuất và tổng hợp chính thức chưa hoàn tất.

Kết quả mô phỏng: Một bảng tích hợp tám miền cho thấy có thể trình bày bằng chứng theo thẩm quyền, phạm vi và loại bằng chứng thay vì quy đổi thành một điểm trường thành. Sơ đồ PRISMA chỉ là cấu trúc giả lập, không phải count chính thức.

Kết luận: Hợp đồng trình bày có thể thực hiện về mặt cấu trúc. Gate G7 chỉ có thể được xác nhận sau khi người chịu trách nhiệm kiểm tra citations, định dạng và số trang trên template tạp chí.

Từ khóa: trí tuệ nhân tạo; đạo đức AI; quản trị AI; y học; Việt Nam; scoping review.

English abstract

Background: AI in medicine requires controls for safety, patient rights, equity, accountability, and oversight. Public evidence in Vietnam is distributed across scholarly and official sources.

Objective: To test whether a Vietnam-focused scoping review can meet the journal's eight-page format.

Methods: This mock manuscript follows the registered protocol and uses 25 representative references and 16 traceable Vietnamese simulation records. No official screening, extraction, synthesis, or PRISMA count has occurred.

Mock results: An eight-domain evidence table and a mock PRISMA structure fit within the proposed article architecture.

Conclusion: The reporting architecture is feasible, pending human verification of citations, journal layout, and page count.

Đặt vấn đề

AI được đưa vào y học qua các hệ thống hỗ trợ quyết định, dự báo nguy cơ, xử lý ngôn ngữ và quản trị dữ liệu. Câu hỏi quản trị không chỉ nằm ở độ chính xác của mô hình mà còn ở ai chịu trách nhiệm, người bệnh biết gì, dữ liệu được bảo vệ ra sao và tổ chức lưu bằng chứng kiểm soát thế nào [3–5].

Tổng quan này dự kiến bản đồ hóa bằng chứng công khai về các khung đạo đức và quản trị AI liên quan y học tại Việt Nam, rồi đối chiếu chúng với bộ chuẩn quốc tế đã khóa. Bản thử này không trả lời câu hỏi nghiên cứu; nó kiểm tra xem cấu trúc báo cáo có đủ chỗ cho bằng chứng, giới hạn và các trường quyết định hay không.

Phương pháp

Protocol được đăng ký tại OSF (10.17605/OSF.IO/62B8W). Thiết kế theo JBI và PRISMA-ScR [1,2]. Nguồn dự kiến gồm PubMed, OpenAlex, các cổng nhà nước, Bộ Y tế và đơn vị trực thuộc,

Bộ KH&CN, WHO/UNESCO tại Việt Nam, cùng khung sentinel đã khóa. Hai reviewer sẽ sàng lọc độc lập theo codebook đã đăng ký.

Mock này dùng 16 record Việt Nam để kiểm tra dung lượng bảng và reference budget. Các record vẫn ở trạng thái SIMULATED_FOR_G7_ONLY; chúng không được xem là nguồn đã chọn. Các trường tài trợ, vai trò nhà tài trợ và xung đột lợi ích được ghi là NOT_REPORTED cho mục đích thử form, cần kiểm tra lại ở toàn văn nếu record được đưa vào nghiên cứu.

Sơ đồ PRISMA-ScR giả lập

Identification (mock only)
Database / portal records [N giả lập]
Records after deduplication [N giả lập]
Screening (not started)
Title/abstract screened [0]
Full texts assessed [0]
Included (not determined) [0]

Các ngoặc vuông là placeholder có chủ đích. Chúng không phải PRISMA count và phải được thay bằng dữ liệu registry đã kiểm toán sau khi screening hoàn tất.

Bảng tích hợp mô phỏng

Miền quản trị

Câu hỏi charting

Dạng bằng chứng cần có

Cách báo cáo trong bài chính

1. Mục đích và phạm vi

AI phục vụ quyết định nào, cho ai?

chính sách, hướng dẫn, nghiên cứu

phạm vi theo tổ chức/cơ sở

2. Thẩm quyền và trách nhiệm

ai phê duyệt, giám sát, xử lý sự cố?

pháp lý, quy chế, báo cáo
tăng thẩm quyền và locator

3. Dữ liệu và quyền riêng tư
dữ liệu, đồng ý và truy cập được kiểm soát thế nào?

quy định, quy trình, đánh giá
phát biểu nguồn, không suy diễn

4. An toàn và hiệu năng
có đánh giá trước/sau triển khai?

ngghiên cứu, audit, báo cáo
thiết kế và giới hạn suy luận

5. Công bằng
bias, đại diện và tiếp cận được xem xét không?

ngghiên cứu, chính sách
phạm vi dân số và thiếu hụt

6. Minh bạch và giải thích
người dùng/người bệnh nhận thông tin gì?

hướng dẫn, tài liệu vận hành
chủ thể nhận thông tin

7. Giám sát và khắc phục
có log, phản hồi, khiếu nại, redress?

quy trình, báo cáo sự cố
bằng chứng hoạt động tách pháp lý

8. Năng lực và tác động
có đào tạo, uptake hoặc outcome được đo?

đánh giá triển khai/kết quả
không gọi là tác động nếu thiết kế không hỗ trợ

Diễn giải mock: Bảng giới hạn ở tám hàng.
Trong bài chính, mỗi trạng thái chỉ được gán sau khi nguồn đủ điều kiện đã được chart, hai reviewer đồng thuận và thẩm quyền/phạm vi được kiểm tra.

Nguồn Việt Nam mô phỏng để kiểm tra khả năng truy vết
Để không làm vỡ layout, bảng truy vết dùng một cột văn bản có cấu trúc. Mỗi dòng giữ đủ trường: **năm; loại; phạm vi/thẩm quyền | phát biểu cần kiểm tra | giới hạn | tài trợ; vai trò tài trợ; COL.**

ID mock / registry

Dòng truy vết mô phỏng

VN-01 / REC-0017

2019; bài nghiên cứu; hệ thống thông tin y tế VN

VN-02 / REC-0034

2021; bài nghiên cứu; ICU VN

VN-03 / REC-0055

2022; bài nghiên cứu; dengue bệnh viện

VN-04 / REC-0060

2022; scoping review; hospital care VN

VN-05 / REC-0066

2022; conference chapter; bệnh viện VN

VN-06 / REC-0074

2022; bài nghiên cứu; tăng huyết áp VN

VN-07 / REC-0086

2022; bài nghiên cứu; phụ nữ Việt Nam

VN-08 / REC-0092

2023; validation study; COVID-19 VN

VN-09 / REC-0105

2023; commentary; Việt Nam

VN-10 / REC-0109

2023; bài nghiên cứu; triệu chứng tiếng Việt

VN-11 / REC-0114

2023; preprint; 5 bệnh viện VN

VN-12 / REC-0147

2024; bài nghiên cứu; Đông Nam Á

VN-13 / REC-0155

2024; trial protocol; phụ nữ Việt Nam

VN-14 / REC-0184

2025; qualitative study; Đông Nam Á

VN-15 / LEGAL:134/2025/QH15

2025; luật; quốc gia

VN-16 / LEGAL:05/2026/TT-BKHCN

2026; thông tư; cơ quan/dịch vụ công

Bàn luận và giới hạn của mock

Mock xác nhận rằng hai tóm tắt, một sơ đồ PRISMA, bảng tám miền, bảng truy vết 16 nguồn và 25 tham chiếu có thể đặt trong một bài ngắn. Nó không chứng minh bằng chứng đã đủ, không hợp thức hóa bất kỳ PDF hay locator nào, và không cho phép mở screening khi G6/G7 chưa được người chịu trách nhiệm xác nhận.

Giới hạn chính là các record Việt Nam mới được dùng để thử cấu trúc bảng. Toàn văn, loại nguồn, thẩm quyền, funding và COI phải được reviewer kiểm tra tại các giai đoạn đã đăng ký.

Đạo đức, tài trợ và sử dụng AI

Nghiên cứu sử dụng tài liệu công khai, không tuyển người tham gia và không tạo dữ liệu cá nhân mới. Tài trợ nghiên cứu và vai trò nhà tài trợ của nghiên cứu được khai báo

NOT APPLICABLE; xung đột lợi ích của nhóm nghiên cứu được khai báo theo hồ sơ đã đăng ký. Công cụ AI chỉ hỗ trợ tổ chức dữ liệu và kiểm tra cấu trúc; con người chịu trách nhiệm về tìm kiếm, screening, trích xuất, trích dẫn và diễn giải.

Tài liệu tham khảo đại diện (25 slot mock)

Peters MDJ, et al. JBI guidance for scoping reviews. M-01; citation NLM cần được reviewer khóa.

Tricco AC, et al. PRISMA Extension for Scoping Reviews. Ann Intern Med. 2018. M-02.

World Health Organization. *Ethics and governance of artificial intelligence for health*. 2021. B1.

UNESCO. *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. 2021. B2.

Lekadir K, et al. FUTURE-AI. BMJ. 2025;388:e081554. B3.

Wang A, Freeman S, Magrabi F. Governance for safe and responsible AI in healthcare organisations. npj Digit Med. 2026;9:516. B4.

Alami H, et al. Artificial Intelligence Governance in Health Systems. J Med Internet Res. 2026;28:e87448. B5.

National Institute of Standards and Technology. *AI RMF 1.0*. 2023. S1.

Đào Trung Thành. *Đạo đức AI: Nguyên tắc và Thực hành*. Chương 10. C10-01.

Vuong QH, et al. *Artificial Intelligence vs. Natural Stupidity*. 2019. doi:10.3390/jcm8020168. REC-0017.

Vital sign monitoring using wearable devices in a Vietnamese intensive care unit. 2021. doi:10.1136/bmjinnov-2021-000707. REC-0034.

Applied machine learning for risk-stratification ... dengue in Vietnam. 2022. doi:10.1371/journal.pdig.0000005. REC-0055.

Tran BX, et al. *Digital Health Policy and Programs for Hospital Care in Vietnam*. 2022. doi:10.2196/32392. REC-0060.

Applications of Statistic Softwares, IT and Artificial Intelligence ... Vietnam Hospitals. 2022. doi:10.1007/978-981-16-9756-2_18. REC-0066.

Predicting Hypertension Based on Machine Learning Methods: A Case Study in Northwest Vietnam. 2022. doi:10.1007/s11036-022-01984-w. REC-0074.

Predicting the risk of osteoporosis in older Vietnamese women using machine learning approaches. 2022. doi:10.1038/s41598-022-24181-x. REC-0086.

Multidimensional Machine Learning for Assessing Parameters Associated With COVID-19 in Vietnam. 2023. doi:10.2196/42895. REC-0092.

Applying artificial intelligence and digital health technologies, Viet Nam. 2023. doi:10.2471/BLT.22.289423. REC-0105.

PhoBERT: Application in Disease Classification based on Vietnamese Symptom Analysis. 2023. doi:10.2478/acss-2023-0004. REC-0109.

Digital health technology adoption in five Vietnamese hospitals. 2023.

doi:10.2196/preprints.53483. REC-0114.

A simple nomogram to predict dengue shock syndrome. 2024. doi:10.1002/jmv.29874.

REC-0147.

The i-CanManage program ... Vietnamese women after cancer. 2024.

doi:10.1177/20552076241293974. REC-0155.

Insights Into AI Adoption Within Health Systems in Southeast Asia. 2025. doi:10.2196/71591.

REC-0184.

Việt Nam. Luật Trí tuệ nhân tạo, 134/2025/QH15. VN-15; locator chính thức cần xác minh toàn văn.

Bộ Khoa học và Công nghệ. 05/2026/TT-BKHCN. VN-16; locator chính thức cần xác minh toàn văn.

Checklist G7 còn phải xác nhận bằng con người: citation NLM của M-01/M-02; locator/toàn văn của 16 record; layout trên template tạp chí; tổng số trang nội dung $\leq 7,4$ và dự phòng 0,6 trang. Cho đến khi bốn kiểm tra này được ghi nhận, trạng thái G7 không được chuyển sang PASS.